

21 - Les prolapsus Genital - Pr. Aboufalah

On va traiter le problème des prolapsus génitaux. On va commencer par la définition. Un prolapsus génital désigne la chute d'un organe pelvien.

Cette chute est permanente ou à l'effort. Ils vont descendre soit au niveau du vagin, ils peuvent même s'extérioriser à travers le vagin. Il survient suite à un relâchement ou une détérioration des moyens de fixité des organes pelviens.

Le prolapsus pelvien est un problème fréquent qui survient surtout chez la femme âgée, en post-ménopause, mais il peut se voir aussi chez la femme jeune active. Par définition, il s'agit d'une pathologie fonctionnelle qui va engendrer une certaine gêne, mais dans des cas extrêmes, on peut avoir un retentissement sur le haut appareil urinaire parce que la viscée qui sort du vagin, il y a les urtères qui peuvent se couder aussi, avec la possibilité d'avoir une hydronephrose bilatérale qui peut être source d'insuffisance rénale, mais vraiment dans les cas historiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'une pathologie fonctionnelle.

Quand on parle de prolapsus, souvent il est associé à des troubles glastatiques pelviennes, y compris au niveau urinaire, on peut avoir une incontinence urinaire qui est souvent associée jusqu'à 70% des cas, et aussi une incontinence anale. C'est ce qu'on appelle dans le cadre de troubles glastatiques pelviennes. Alors le traitement, bien évidemment, il doit tenir compte, il faut toujours savoir que c'est une pathologie fonctionnelle, donc le traitement ne va pas vider à corriger les anomalies anatomiques, mais il faut essayer de comprendre la gêne fonctionnelle et les plaintes de la patiente, parce qu'on vise la correction de la fonction plutôt que de l'anatomie, parce qu'on peut avoir des prolapsus extériorisés et la patiente ne se plaint pas de rien du tout.

Dans ce cas-là, il ne faut pas aller opérer ces femmes-là. Alors quels sont les facteurs de risque ? Les facteurs de risque, bien évidemment, c'est une pathologie qui est presque, à plus de 90% des cas, liée à des problèmes obstétriques, à des accouchements parfois difficiles avec des déchirures au niveau du périnée et du moulin de fixité, et cette situation va s'aggraver au moment de la ménopause parce qu'il y a une suppression des oestrogènes en particulier qui va aggraver ce problème de la trophicité au niveau du vagin, mais aussi au niveau des différents ligaments. Donc il y a des facteurs congénitaux qui naissent avec la patiente.

On sait qu'il y a beaucoup de gènes impliqués dans la synthèse du collagène et en cas de mutation, on peut avoir des altérations du collagène avec un risque élevé d'avoir installé un prolapsus. Tout ce qui est trouble aussi de la statique pélvienne, l'hyperlordose, et puis on va trouver chez certaines patientes une hyperlaxité ligamentaire pathologique. C'est pourquoi il y a des prolapsus qui surviennent chez une nullipare.

On n'a jamais accouché et pourtant on peut avoir des prolapsus même chez la jeune fille. Et puis il y a le syndrome Danlos, c'est toujours par un trouble conjonctif et il est souvent associé à une

incontinence urinaire dans 60% des cas, dans 30% des cas on aura un prolapsus. Mais le plus fréquent, dans plus de 90% des cas, c'est le facteur acquis, en particulier le traumatisme obstétrique.

On va retrouver le traumatisme chirurgical, il y a des modifications statiques. On peut avoir surtout dans les prolapsus du dôme vaginal après une hystérectomie. C'est pourquoi dans les hystérectomies simples, il faut laisser le vagin attaché aux histérosacrés, pour prévenir par la suite un prolapsus du dôme vaginal.

Donc le traumatisme obstétrique peut être une cause de prolapsus. Donc les hystérectomies, c'est après une hystérectomie qui ne respecte pas l'anatomie, on a quand même 20% d'incontinence urinaire qui s'installe par la suite. Tout ce qui est chirurgie de l'incontinence urinaire ou du prolapsus, il y a aussi des modifications dans l'innervation en particulier, par la chirurgie itérative, surtout dans la chirurgie pélvienne pour des cancers, et puis dans l'insuffisance sphinctérée.

Ce qu'il faut retenir, c'est surtout le traumatisme obstétrique associé au vieillissement, parce que souvent cette pathologie se manifeste juste après la ménopause. Donc il y a un vieillissement des fascias et des ligaments, en particulier les lames élastiques, qui sont remplacées par du collagène, et il y a une atrophie musculaire, et ces muscles seront remplacés par de la fibrose. Mais c'est surtout, toutes ces anomalies-là, c'est la carence en oestrogène après la ménopause, donc il y a une diminution de la vascularisation et l'atrophie vaginale.

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à part les ligaments de suspension, les différents éléments anatomiques du pelvis, la viscère en avant, l'appareil génital au milieu et l'appareil digestif en arrière, se disposent en marche d'escalier. Le vagin représente le pivot dans cette statistique. Une fois que vous avez une altération des éléments de suspension d'un de ces organes-là, en général, les autres organes périeurs vont accompagner la descente de cet organe.

C'est pourquoi ils sont souvent associés. La carence oestrogénique va entraîner une perte des propriétés biomécaniques du vagin. De même pour le détrusor et la vascularisation de l'urètre et la chute de la pression de clôture.

Il y a d'autres facteurs, c'est par augmentation des efforts subis, en particulier dans les activités physiques intenses. C'est quelque chose de très très important chez la femme, c'est que s'il fait de l'effort physique, il faut qu'il commence par une rééducation périnéale. Parce que si on ne renforce pas la musculature des périnées, du fait du renforcement de la musculature abdominale, il y a une hyperpression intra-abdominale qui va pousser le plancher périnéal, qui va fragiliser le plancher périnéal.

C'est pourquoi il est recommandé, surtout en postpartum, que les femmes ne regardent que leur ventre. Elles vont faire de la rééducation abdominale sans faire la rééducation périnéale. Il est conseillé de commencer à faire de la rééducation périnéale après l'accouchement, avant

d'entamer la rééducation du muscle de l'abdomen.

Tout travaille avec des efforts importants, les modifications de l'axe des forces, l'âge de la syphose d'OBSA, l'insuffisance respiratoire chronique par la toux. La toux produit une hyperpression intra-abdominale qui peut être délétère pour la statique puvienne. De même, les modifications thoraciques, la paroi abdominale, la constipation chronique parce que la femme pousse, pousse, pousse, il y a une détérioration même nerveuse qui va aggraver la situation.

Il faut obligatoirement, s'il y a une toux chronique, il faut la traiter. S'il y a une constipation chronique, il faut la traiter. Mais surtout le traumatisme occipital et le risque même en cas de césarienne parce que du fait du poids du bébé durant toute la grossesse, il y a une élangation, une atteinte des éléments de suspension, en particulier du ligament.

On a même décrit une atteinte nerveuse avec une diminution de la force musculaire suite à la grossesse. C'est pourquoi il est recommandé actuellement, même en cas de césarienne, de faire la rééducation du périnée avant de s'attaquer à l'abdomen, même en cas de césarienne. Mais surtout les accouchements par voie basse traumatiques, quand on a un macro-asthme par exemple, dans les extractions instrumentales, quand il y a une déchirure périnéale, tout ça peut engendrer par la suite un prolapsus.

Et puis le prolapsus se voit beaucoup plus chez la femme obèse. Et puis dans les régimes agressifs pour l'obésité, le fait d'avoir une chute rapide du poids peut favoriser l'apparition du prolapsus. Et bien évidemment, la fréquence de cette pathologie dépend directement de la parité.

Alors juste un rappel anatomique, vous avez le compartiment antérieur qui est représenté ici par la viscille et l'urètre. Et puis le compartiment supérieur apical par la voûte du vagin et le compartiment postérieur par le rectum, l'anus et les ongles. Ce sont des ongles qui descendent à travers le cul de sexe de glace et on peut avoir ce qu'on appelle l'élytrocèle.

C'est un prolapsus du cul de sexe de glace qui peut sortir à l'extérieur et il peut contenir aussi les ongles intestinales. Et puis vous avez le support du plancher pélvien, en particulier par les muscles releveurs de l'anus qui représentent un moyen de soutènement, pas de suspension, de soutènement des différents organes pélvien. Voilà les différents faisceaux des muscles releveurs de l'anus qui représentent une pierre angulaire dans le soutènement des organes pélvien.

Quelques définitions quand on parle de la descente ou de la chute d'organes. Quand il s'agit de la viscée, on parle de cystocèle. Quand il s'agit du rectum, c'est une rectocèle.

Quand on parle de chute de l'utérus, prolapsus utérin, ou hystérocèle. Quand il s'agit de la descente de la voûte du vagin, c'est la colpocèle. On peut dire que la colpocèle antérieure est l'équivalent de la cystocèle et la colpocèle postérieure est l'équivalent de la rectocèle.

Et puis la descente, en particulier de l'intestin du grêle, appelée entérocele, se fait toujours à travers le cul du sac de Douglas. La descente au niveau du cul du sac de Douglas s'appelle élytrocele. Souvent, on parle de la cystocèle, c'est-à-dire la colpocèle antérieure, la rectocèle derrière, ou la colpocèle postérieure, et l'hystérocele qui concerne l'utérus.

Mais dans des cas beaucoup plus avancés, on peut avoir la descente des onces gréliques à travers le cul du sac de Douglas, élytrocele, et quand le contenu de l'intestin, ça s'appelle entérocele. Comme toute pathologie fonctionnelle, dans l'étude clinique, l'interrogatoire prend une importance capitale parce qu'il va essentiellement se concentrer sur l'importance de la plainte des patients et l'importance de la gêne occasionnée par cette pathologie. L'interrogatoire va rechercher les troubles fonctionnels, les troubles fonctionnels au niveau de la marche, les troubles urinaires, les troubles digestifs.

Il va apprécier, évaluer l'importance de la gêne occasionnée et aussi le retentissement sur la vie socioprofessionnelle et sexuelle chez la patiente. Évidemment, il va chercher des antécédents médicaux, obstétricaux et chirurgicaux pour essayer d'avoir une vision sur l'éthiopathogénie ou la physiopathologie du prolapsus. L'interrogatoire va apprécier essentiellement les signes fonctionnels urinaires, en particulier à la recherche d'une incontinence urinaire.

Cette incontinence urinaire, s'il est présente, il faut la classer. C'est quelque chose de très important. Il faut voir si cette incontinence urinaire survient juste au moment de l'effort, à la marche, à la course, quand la patiente tousse, quand elle rit.

Ça, c'est l'incontinence urinaire d'effort qui survient comme au moment d'effort. La fuite urinaire survient juste après l'effort. Il faut voir s'il y a une incontinence urinaire permanente, parce que le mécanisme est différent et le traitement est différent aussi.

L'incontinence urinaire d'effort, c'est beaucoup plus un problème d'ordre chirurgical, comme le prolapsus. Mais l'incontinence urinaire permanente, quand vous avez des fuites d'une manière permanente, là, il faut chercher autre chose. Soit des troubles neurologiques, surtout chez la diabétique, ou quand vous avez une chirurgie agressive au niveau du pelvis, ou quand vous avez une viscèle à tonnes et par la suite, il y aura de l'incontinence urinaire d'une manière permanente.

Et puis, il faut voir à ce que cette incontinence survient par impériosité. Alors, l'incontinence urinaire par impériosité, la patiente, suite à un stimulateur, elle va aller courir pour faire pipi, mais sans qu'il y ait forcément une fuite d'urine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impériosité mexionnelle.

Et là, ce n'est pas la correction des troubles de la statique pélvienne qui vont arranger le problème, mais c'est plutôt un traitement médical. Il y a des scores pour quantifier l'importance de la fuite. C'est très important, c'est en général par le nombre de couches que la patiente change par jour, pour juste avoir une idée sur l'importance et aussi sur la fréquence.

Donc, l'incontinence urinaire des folles, c'est quelque chose de très, très important, de voir si,

obligatoirement, c'est la première question qu'on pose après le diagnostic de prolapsus, c'est de voir s'il y a une incontinence urinaire associée. Et puis, la classe C, c'est juste les incontinenances urinaires des folles qui peuvent être corrigées par la chirurgie. Alors, la dysurie, c'est la difficulté de vidange.

Des fois, quand vous avez la viscille à l'extérieur, souvent la patiente est obligée de réintroduire la viscille pour uriner. Cette notion est la capitale. En présence de cette dysurie, on peut prévoir les troubles urinaires postchirurgicaux.

Quand on fait une correction, si la patiente est dysurique, et si on fait un geste très agressif, on risque d'aggraver cette dysurie. Donc, cette notion est capitale pour la prise en charge par la suite et surtout pour la prise en charge des complications du traitement de prolapsus. Alors, la stabilité physique, c'est l'impérialité, donc c'est des urgences mixionnelles associées à des brûlures mixionnelles.

Là, bien évidemment, il faut faire un examen cytopactériologique des urines pour éliminer une infection avant de retenir l'instabilité physique. Et là, c'est un problème d'ordre médical, pas chirurgical. Et on voit, est-ce que la patiente, pour sortir ou aller au travail, ou faire ses courses, est-ce qu'elle a besoin de porte de protection et combien elle les change par la suite.

Et puis, on peut établir ce qu'on appelle un catalogue mixionnel sur trois jours. Tout ça pour apprécier l'importance du gêne associé. Donc, ce qu'on appelle, c'est une mesure du handicap urinaire.

Alors, l'incontinence anale aussi, elle est présente dans les troubles de la statique péruvienne puisqu'elle représente 10. Elle est associée à l'incontinence urinaire ou au prolapsus dans 10 à 20 % des cas. Cette incontinence, il faut à l'interrogatoire chercher s'il est juste à l'effort ou il est spontané et s'il est juste, il y a une incontinence au gaz et s'il est au solide, il faut voir ce que pour les matières juste liquides ou matières solides.

Et puis, la constipation, c'est quelque chose de très, très important. Donc, il faut voir le mécanisme. Alors, des fois, vous avez une rectocelle très, très importante et la patiente, elle va se constiper avec des difficultés de défécation.

Et là, la patiente apprend vite qu'il faut réintroduire le rectum dans l'enceinte pour faire ses besoins correctement. Il y a des patientes souvent qui sont suivies chez le gastro pendant très longtemps pour constipation alors que le mécanisme, c'est juste par le prolapsus. Donc, à chaque fois qu'il y a une constipation chez la femme, surtout après la ménopause, il faut faire un examen gynécologique à la recherche d'une rectocelle.

Et puis, tout ce qu'on peut voir au niveau urinaire, on le voit moins fréquemment au niveau digestif. Donc, il faut mesurer aussi la gêne occasionnée et le handicap digestif. Alors, les signes associés, c'est très, très important de chercher s'il y a des troubles sexuels.

Et souvent, la patiente, elle ne va pas parler de sa sexualité. C'est des femmes souvent âgées, elles vont parler d'autre chose. Mais il faut toujours aborder la sexualité chez ces femmes-là, surtout pour le traitement.

Et ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut jamais tenir compte juste de l'âge. Ça fait trois ou quatre mois, je voulais opérer un prolapsus chez une femme qui a presque 90 ans.

Sans ma vie, elle a presque un centenaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire à la femme? Donc, en général, on peut faire une occlusion du vagin. Ça fait partie du traitement du prolapsus.

Et c'est lui qui me dit, voilà, on est encore actifs sur le plan sexuel. C'est quelque chose de très, très important d'y penser. Voir si la dame a des rapports sexuels ou pas.

Il y a même beaucoup d'étrangères qui se sont installés à Marrakech, qui sont d'un certain âge, qui se remarient avec un jeune. Et nous, on ne pense plus à leur sexualité. On risque de trouver des surprises.

C'est pourquoi, quel que soit le cas de la femme, il ne faut pas avoir de préjugés. Il faut demander auprès de sa sexualité. Souvent, la patiente ne va pas consulter pour une descente d'organes.

Elle va vous dire, voilà, j'ai une pesanteur au niveau puvien. Il faut penser au prolapsus, examiner la dame. Et il y en a qui vont vous dire, dans 50% des cas, écoutez docteur, je sens une boule au niveau du vagin.

Là, on va penser directement au prolapsus. Alors dans le prolapsus extériorisé, il y a des femmes qui marchent normalement. Normalement, il y a des femmes, même pour un prolapsus deuxième ou troisième degré, elles vont avoir des difficultés à marcher.

Elles gênent à la marche. Donc il faut demander à la femme s'elle est gênée quand elle marche. Et puis, demandez toujours, quand elle veut faire pipi, est-ce qu'elle est obligée d'introduire les doigts ou la main au niveau du vagin.

Même pour faire ses selles, est-ce qu'elle est obligée de réintégrer les organes pour faire ses besoins. Et puis, il y a des douleurs, mais en général, ce n'est pas une pathologie douloureuse. Souvent, il y a beaucoup de femmes qui me consultent parce qu'elles ont des douleurs pérennales ou des douleurs pélvienues.

Et quand on fait l'examen, on trouve un prolapsus de premier degré, une petite cystoselle avec une petite hystéroptose qui ne va pas expliquer les douleurs qu'elles ressentent. Donc il faut faire très attention à ces patients-là pour ne pas les opérer parce qu'ils ont un prolapsus de grades 1 ou 2. Parce que la douleur ne peut pas être expliquée par le prolapsus. Donc il faut aller chercher autre chose, soit de la neuropathie pudendale quand il s'agit des douleurs pérennales ou quand il

s'agit des douleurs pélviennes.

Il faut aller chercher d'autres étiologies plutôt que de relier ces douleurs au prolapsus. Donc vraiment, il faut faire très attention. On a vu des patients opérés pour prolapsus mineur et qui se retrouvent dans un cercle vicieux parce qu'après l'opération, ils vont continuer à se plaindre et peuvent même porter plainte contre le médecin.

Donc ça, c'est quelque chose de capital. Donc en général, le prolapsus n'est pas douloureux, donc il faut aller chercher autre chose. Et souvent des patients qui viennent et qui insistent, ils ont vu plusieurs médecins qui insistent pour se faire opérer.

Et souvent, dans pas mal de cas, il s'agit d'une dépression masquée par les somatises. Alors que si on demande, on étudie la qualité de sommeil, est-ce qu'il y a eu un accident ou quelque chose au niveau de la famille, on va trouver que c'est la dépression qui conduit ces femmes à venir consulter. Et puis quand il est extériorisé, quand on fait l'examen, on va trouver des ulcérations et des fois des météorologies par traumatisme au niveau du col utérin et puis des surinfections, qu'elles soient vaginales ou urinaires.

Donc l'interrogatoire, c'est l'élément clé, aussi bien pour le diagnostic, mais surtout pour étudier le retentissement, la gêne occasionnée avant de faire l'examen physique. Donc l'examen doit se faire soit avec des valves ou le spiculum, mais les valves, c'est mieux, parce que pour voir ce qui se passe au niveau du compartiment antérieur, on doit refouler le compartiment postérieur pour voir ce qui se passe en antérieur, et de même pour voir ce qui se passe au niveau du compartiment postérieur, il faut refouler le compartiment antérieur. Donc l'examen sous valve, il est mieux que l'examen sous spiculum.

Alors cet examen se fait au repos et puis on va demander à la patiente de tousser, de pousser et stagifier au repos et aussi à l'effort. Et puis l'examen, des fois, quand on fait l'examen en position couchée, position gynécologique, on ne va pas trouver grand-chose, mais la dame vous dit, écoutez, quand je me lève, quand je marche, il y a quelque chose. Donc là, c'est pourquoi il faut faire l'examen aussi en position, des fois, faire l'examen en position debout pour voir ce qui se passe.

De même, des fois, normalement l'examen est fait à vis-à-vis, mais en matière de prolapsus, il faut toujours remplir, soit remplir la vis-à-vis par une sonde visicole, soit demander à la patiente de boire et puis lui demander de tousser et voir la descente de la viscille de leur être, mais aussi est-ce qu'il y a une perte, une fuite d'urine ou pas, pour dire est-ce qu'il y a une incontinence ou pas. Donc c'est obligatoirement, l'examen doit commencer par une viscille vide et il faut le compléter par une viscille pleine pour voir l'importance de la descente de la cystoselle, mais aussi pour voir est-ce qu'il y a une incontinence urinaire d'effort ou pas. Ça ne sert à rien de demander à la patiente de tousser pour chercher une incontinence alors que la viscille est vide.

Donc il faut remplir la viscille avant de demander, avant de chercher une incontinence urinaire.

Alors l'examen gynécologique doit être complet, il faut voir ce qui se passe au niveau du col, au niveau du vagin, au niveau de la vulve. Il faut chercher avec le toucher vaginal associé au palpé abdominal s'il n'y a pas une tumeur.

Il y a pas mal de cas où il y a des tumeurs, on a le prolapsus parce qu'il y a une masse abdominopelvienne qui pousse sur le plancher pelvien. Puis on va demander à la patiente de contracter la musculature, en particulier le muscle releveur, de contracter la musculature et on va grader, on va faire un testing musculaire et le grader de 0 à 5. C'est très très important parce que si on voit que le tonus n'est pas très très important, là on peut proposer par exemple la rééducation du périnée. Donc tout ça c'est quelque chose de très très important qui va nous orienter par la suite pour le traitement.

Alors c'est très important, on ne va pas toujours trouver le même grade quand on grade le compartiment antérieur, moyen et postérieur. On peut trouver les trois éléments au même grade dans le prolapsus complètement extériorisé. Mais des fois vous avez par exemple les sérocelles de grade 3, les cistocelles de grade 2 et les rectocelles de grade 1. Souvent les grades sont différents, mais souvent, dans plus de 90% des cas, le prolapsus va concerner les trois compartiments mais d'une manière différente.

Des fois on a par exemple une sérocelle de troisième degré, une rectocelle de premier degré, et quand on opère ces patientes-là sans faire un geste sur le compartiment postérieur, juste après la chirurgie ou quelques mois après la chirurgie, on aura l'installation d'une rectocelle. Parce que l'utérus fait comme un bouchon, et dès qu'on fait l'hystérectomie, il y a la descente de la viscille et du rectum, si on ne fait pas attention, si on ne corrige pas tous les compartiments. Malheureusement ça arrive souvent, surtout dans le contexte marocain, où les prolapsus sont traités par simple hystérectomie.

Et là on va aggraver la situation parce qu'on va avoir l'installation de la sortie complète de la viscille et aussi du rectum. Donc jamais d'hystérectomie simple, même pour une séroptose isolée. Il faut toujours corriger les autres compartiments.

Pour les stades, il y en a plusieurs classifications, la plus simple c'est le stade 1, quand vous avez les différents organes, ils sont indécents, mais ils sont toujours à l'intérieur du vagin, on ne les voit pas sauf quand on fait l'examen sous spiculum ou sous valve. Donc c'est le prolapsus intravaginal. Dans le stade 2, c'est que les organes affleurent l'orifice vulvaire.

Et ça on le dit pour le compartiment antérieur, pour la viscille, pour l'utérus et pour le rectum. Donc il faut stadifier chaque élément. Et puis quand il est complètement extériorisé, il sort de l'orifice vulvaire, c'est un grade, un stade 3. Donc là on voit la relaxation, là c'est la cistocèle, là vous voyez le relâchement des différents muscles périnéés avec le rectocèle.

Là c'est la cistocèle, vous voyez quand la viscille est vide, soit prendre une pince anatomique et

tirer sur la paroi vaginale antérieure pour voir le degré de la descente, sinon il faut remplir la viscille pour voir l'importance de la cistocèle. Là vous voyez la détérioration des moyens de soutiennement du plancher pélvien, mais aussi les différents moyens de suspension. Et là vous avez un prolapsus qui touche tous les compartiments.

Dans la majorité des cas, dans le contexte marocain, on va trouver ceci. Donc c'est des prolapsus un peu plus de stade 3, c'est un stade 4. Et là on a eu des surprises, même dans ma vie j'ai opéré 4 ou 5 prolapsus irréductibles avec insuffisance rénale. C'est la seule urgence où on peut opérer un prolapsus en urgence quand ça devient irréductible.

Donc la patiente va avoir une rétention physique, elle n'arrive plus à faire ni ses selles ni ses urines avec une insuffisance rénale d'origine obstructive. Mais c'est des cas heureusement exceptionnels. Là c'est sur les différents éléments de l'examen.

Donc on regarde au propos de ce qui se passe, on met une valve antérieure, postérieure, antérieure pour voir ce qui se passe au niveau du compartiment moyen et postérieur. Et puis on met une valve pour voir ce qui se passe au niveau de la visée et de l'urètre. Alors l'incontinence urinale est gradée, classée aussi, si elle est présente.

Donc 0 c'est pas d'incontinence, score 1 à l'atout lors des forêts importantes, 2 lors des activités courantes, levées, marches, escaliers, et puis grade 3 quand elle est permanente. Alors au niveau de quelles sont les manœuvres qu'on peut effectuer pour sensibiliser l'examen. Donc la manœuvre de valve que je viens de dire, quand vous avez l'utérus qui sort, on ne voit que l'utérus et on ne voit pas ce qui se passe au niveau du rectum.

Donc il faut refouler par une valve l'utérus et la visée, et voir ce qui se passe au niveau de la corde postérieure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une rectocèle ou pas. Le fait juste de voir ce qui se passe au repos, ça ne reflète pas la réalité. C'est pourquoi il faut utiliser ces manœuvres des valves pour ne pas passer à côté d'un prolapsus des autres étages.

Alors des fois, vous avez la visée qui sort avec une coudure au niveau du rectum, et on va demander à la patiente de pousser pour voir s'il y a une incontinence. Il ne va pas y avoir de fuite, alors que réellement, quand on réintroduit la visée, on corrige la coudure et on voit que la patiente est incontinente. Donc c'est quelque chose de très important pour chercher l'incontinence, de remettre la visée à sa place.

Et puis vous avez, pour l'étude de l'incontinence urinaire, la possibilité de la correction chirurgicale. On fait la manœuvre de Bonnet, la manœuvre de Val Zalva. Et l'épreuve d'Elmstein, ça c'est dans un but chirurgical.

Donc ce qu'on fait, normalement on corrige la chirurgie de l'incontinence par une bandelette qu'on passe sous l'uréthrale pour soulever la portion intermédiaire de l'urètre. Alors pour prévoir la réussite de cette opération, on va mettre une pince de part et d'autre de l'urètre dans sa portion

moyenne et les soulever un petit peu et on demande à la patiente de tousser. S'il n'y a plus de fuite, on dit que l'épreuve est positive et qu'il y a de fortes chances que l'intervention pour l'incontinence soit une réussite.

Donc il y a plusieurs tests dans ce sens pour prédire la réussite de la patiente. Puis le pas de test, c'est de peser les protections pour avoir une idée sur l'importance des fuites et bien évidemment il faut toujours faire un testing des muscles d'hypériorionique. Donc le prolapsus, c'est l'interrogatoire et l'examen clinique.

On n'a pas besoin d'autre chose. Ça c'est quelque chose de capital. Donc on peut avoir toutes les notions, le diagnostic positif, mais surtout l'éthiopathogénie du prolapsus ou de l'incontinence, c'est par quel mécanisme, ça c'est important pour le traitement, et surtout l'impact sur la patiente, le retentissement socioprofessionnel, sexuel, de côté fonctionnel, de côté urinaire, de côté digestif, pour proposer un traitement en fonction de ces éléments-là.

Alors bien évidemment quand il y a un prolapsus, il faut demander un ECBI d'une manière systématique, surtout lorsqu'il y a des fuites, il y a des troubles urinaires. Parce qu'ils peuvent être la cause et la conséquence des troubles urinaires. Donc quand vous avez un cystocèle, il y a une stagnation des urines au niveau de la viscille, et on peut avoir une infection urinaire associée.

Donc il faut, surtout avant de faire un geste chirurgical, il faut obligatoirement demander un ECBI pour éliminer une infection urinaire associée. Alors le frottis, il faut faire un frottis obligatoire, parce que par la suite, pour l'intervention, est-ce qu'on va laisser l'utérus, ou on va l'enlever, et ça dépend de l'état médical. Si par exemple vous avez une lésion de bas grade ou de haut grade au niveau du col utérin, on va opter pour des interventions avec l'ablation de l'utérus.

Donc c'est quelque chose de capital de voir, d'examiner le col correctement à la recherche d'une lésion, et demander un frottis d'une manière systématique. Alors l'échographie pelvienne est très importante. Il y a des masses pelviennes qui peuvent expliquer les prolapsus, mais aussi pour le traitement.

Souvent c'est des femmes âgées où il faut faire l'échographie pour voir l'état de l'endomètre. Si par exemple il y a une hypertrophie de l'endomètre à l'échographie, il faut aller faire une hystéroscopie et faire une biopsie avant de proposer un traitement chirurgical pour la patiente. De même, cette échographie, on va demander à la patiente, quand on veut chercher la continuité urinaire, voir à l'échographiste si la viscille est pleine ou pas, et puis on va demander à la patiente d'aller uriner, et je fais l'échographie à la recherche de ce qu'on appelle le résidu post-mixionnel, qui signifie qu'il y a une désurie chez cette patiente-là.

Ça c'est quelque chose de capital pour prédire les complications après le traitement. L'IV ou l'éroscanner, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exceptionnellement quand on les demande. Dans les prolapsus historiques, on peut avoir une erythrohydronephrose unie au

bilatéral avec retentissement rénal.

Quand le mécanisme n'est pas clair des prolapsus, on peut faire des opacifications. On peut remplir le vagin, on peut remplir le rectum et faire une IRM. C'est une IRM dynamique, au repos et au poussé, mais c'est dans des cas vraiment particuliers et ce n'est pas une indication systématique à demander une IRM quand vous êtes devant un prolapsus.

Reste le problème des explorations aérodynamiques. Le bilan aérodynamique repose sur le débit métrique qui apprécie la fonction globale de la miction, l'assistomanométrie qui apprécie le tonnisme physical, surtout à la recherche pour avoir le mécanisme de l'incontinence, est-ce que c'est par impérialité ou c'est une incontinence urinaire. Des fois, quand on suspecte une incontinence urinaire par atteinte sphinctérienne, par insuffisance sphinctérienne, c'est la sphincterotomie qui apprécie les muscles responsables de la continence.

Le bilan aérodynamique aussi n'est pas obligatoire, il n'est pas systématique, mais des fois, à l'interrogatoire et à l'examen clinique, on a du mal à voir le mécanisme des fuites urinaires. Est-ce que c'est juste à l'effort, là on peut le corriger par la chirurgie, ou c'est une incontinence par impérialité, et là c'est plutôt un problème attiré par les médicaments, ou il y a une insuffisance sphinctérienne. Et le danger c'est ça, c'est que ni le traitement médical, ni le traitement chirurgical classique, ni le traitement chirurgical classique par les TOT ou TVT, ne va pas corriger l'incontinence urinaire par atteinte sphinctérienne.

Et là, on va faire l'intervention et la patiente continue à fuir, et par la suite on peut avoir des problèmes avec la patiente. C'est pourquoi le bilan aérodynamique, il peut nous dire, voilà, attention, peut-être qu'il y a une atteinte sphinctérienne et il faut faire attention, et le traitement ne va pas reposer sur le soutènement par bande de l'urètre. Donc quand on n'arrive pas à voir le mécanisme des fuites urinaires, c'est la meilleure indication pour le bilan aérodynamique, sinon il n'est pas demandé d'une manière systématique.

Alors, dans des cas rares, d'hyperspécialisation, on peut avoir recours à une cystographie, une cystoscopie, des explorations neurologiques, en particulier la neuropathie pudendale, et l'IRM des fois dynamique après avoir rempli le vagin et éventuellement le rectum. Donc le diagnostic repose sur l'interrogatoire et l'examen physique. Le retentissement, c'est sur l'interrogatoire parce que sur ces éléments-là, on va décider de la prise en charge, est-ce qu'il faut la laisser tranquille ou il faut l'opérer ou il faut avoir recours à d'autres moyens médicaux.

Donc tout ça repose sur la clinique, puis les explorations. Pas forcément en rapport avec le prolapsus, il faut demander d'une manière systématique d'évaluer le cas luthérien, faire un ECBU. Le reste, ce n'est pas obligatoire, et éventuellement demander un bilan aérodynamique à l'interrogatoire et à l'examen physique.

On n'arrive pas à voir le mécanisme de fuite urinaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut

proposer à la patiente? Il y a des traitements chirurgicaux et non-chirurgicaux. Concernant le traitement non-chirurgical, ça commence toujours par la prévention.

La prévention, c'est quelque chose de capital. Durant la vie active, génitale active, c'est là qu'on doit commencer la prévention. Ce n'est pas à la ménopause pour commencer.

Le premier, c'est d'éliminer le traumatisme obstétrique. C'est savoir manager correctement les accouchements. Dans quelles conditions sont encore réalisés nos accouchements? Avec les poussées, on pousse comme des... je ne sais pas comment.

Au niveau, il faut bannir normalement les expressions au niveau de l'utérus pour accoucher rapidement les patients. Normalement, ça doit être banni de la pratique. Je vous donne aussi l'exemple des épisiotomies.

On fait les épisiotomies n'importe comment. En laissaiture, la réflexion se fait n'importe comment. Et encore, on pose la question sur l'utilité de l'épisiotomie.

Ça n'a jamais montré qu'il prévient ni les échanges du périnée, ni les problèmes à long terme de prolapsus. Donc il faut... les épisiotomies doivent être évitées. Je ne peux pas dire bannir les épisiotomies, mais au moins les limiter à moins de 10% des accouchements.

Peut-être que lorsqu'on est amené à faire un forceps ou quelque chose comme ça, on peut faire l'épisiotomie, mais pour les autres cas, il ne faut pas le faire. Le problème qui se pose chez nous, c'est que si la patiente fait une petite déchirure, tout le monde va se dire qu'il fallait faire l'épisiotomie pour prévenir la déchirure. Mais c'est quoi l'épisiotomie ? C'est une déchirure.

C'est une déchirure hétérogène. Donc il faut qu'on arrête de dire ça. Il vaut mieux accepter une déchirure de premier ou deuxième degré faite spontanément plutôt qu'une épisiotomie mal faite.

Donc avec la patiente, si on fait l'épisiotomie, d'accord, il n'y a pas de problème, mais si on ne fait pas d'épisiotomie et il y a une déchirure, elle va se plaindre. Alors que ce n'est pas logique. Donc il faut réduire le nombre d'épisiotomies, réduire le nombre d'extractions instrumentales difficiles.

Des fois, il vaut mieux faire une césarienne plutôt qu'une extraction instrumentale difficile. Alors il faut dépister les femmes à risque, rechercher les lésions mineures et inaperçues pour les réparer, mais surtout la rééducation. La rééducation doit être proposée à toutes les femmes qui ont accouché par voie basse.

Normalement, toutes les femmes doivent bénéficier de la rééducation du périnée deux mois après l'accouchement, d'accord. Mais si on ne peut pas faire cette rééducation chez toutes les femmes, au moins il faut la faire chez les femmes à risque. Et puis au moment de la ménopause, avec la carence aux oestrogènes, avant on proposait un traitement hormonal substitutif.

On avait la main facile pour prescrire ce traitement-là. Mais vu qu'il y a quand même une petite

augmentation du risque au niveau du cancer du sein, malheureusement le traitement hormonal est limité à certaines femmes qui ont un risque osseux très important, chez qui on peut prescrire un traitement hormonal substitutif. Donc à chaque fois que vous avez des femmes surtout à risque, il faut leur proposer une rééducation périnéale.

Ce sont des contractions volontaires du muscle élévateur de l'anus, rétablissement du verrouillage du périnée. Alors cette rééducation peut se faire chez les kinés, elle peut être manuelle ou par une stimulation électrique. On fait ce qu'on appelle aussi le biofeedback.

Et des fois on peut faire de l'auto-rééducation, on met des cônes intravaginales et on fait des contractions au niveau du vagin. Le plus important, c'est que la majorité des femmes au Maroc ne veulent plus avoir ce ventre après l'accouchement, et elles commencent la rééducation au niveau de l'abdomen sans passer par la rééducation du périnée. Ça c'est dangereux.

Donc il faut obligatoirement qu'elles fassent sa rééducation périnéale avant de faire la rééducation abdominale. Alors le problème aussi, il y a beaucoup de femmes qui ont un rétro contrôle qui n'est pas adapté. Quand on demande à la patiente de pousser, de tousser, ils vont augmenter la pression en intra-abdominal.

Normalement, par un mécanisme réflexe, il y a une contraction de la musculature du périnée. Quand il y a un problème de rétro contrôle, au lieu qu'il contracte les muscles du périnée, elle va faire une relaxation à ce niveau-là. Et ça c'est très grave parce que ces femmes-là vont avoir obligatoirement des problèmes sexuels.

Au moment des rapports sexuels, elles relâchent la musculature et par la suite, il y aura des problèmes de la statique pélvienne. Et ça c'est quelque chose de très simple à corriger par la technique de biofeedback. Typique, c'est ces femmes-là qui ont ce problème et proposer une rééducation par biofeedback.

Alors le traitement hormonal, si on ne donne pas un traitement hormonal substitutif, on peut donner un traitement par voie locale qui va améliorer la proficité au niveau du vagin, mais ne guérit pas un prolapsus, mais on peut améliorer la situation. Par une amélioration de la proficité des tissus, il peut même améliorer certaines plaintes, surtout urinaires. Donc l'ostéogénéthérapie, on peut mettre des moyens pour refouler le prolapsus sur toute la nuit et faire des soins parce que souvent les tissus se dessèchent et on peut avoir des lésions à ce niveau-là.

Il faut traiter les signes digestifs aussi. Il faut obligatoirement traiter s'il y a une constipation chronique, modification de l'alimentation en cas d'incontinence anale, voir s'il y a le gaz et épicer les selles, et une kinésithérapie pérennale de relâchement du muscle pivoirecto et réaliser une information détaillée des échecs et complications possibles quand on opte pour le traitement chirurgical. Il faut expliquer les principes, expliquer les résultats attendus et aussi les complications.

C'est pourquoi on ne traite pas le prolapsus, on traite la plainte. On peut corriger sur le plan anatomique tous ces éléments, les remettre en place et la patiente continue à souffrir. C'est pourquoi il faut voir la plainte de la patiente et se focaliser au niveau du traitement sur sa plainte pour avoir un résultat, pas anatomique, mais un résultat fonctionnel, correct.

Parce que là, c'est une pathologie fonctionnelle. Ce n'est pas parce que j'étais efficace à 100% sur le résultat anatomique qu'il y a une satisfaction chez la patiente par la suite. Ça, c'est capital.

C'est pourquoi il faut une analyse fine des plaintes et la demande de ce que la dame veut. Ça, c'est quelque chose de capital. En général, actuellement, on a de plus en plus de femmes jeunes qui ont un cystocèle de 1 ou 2 ans, elle a 41 ou 45 ans, elle ne se plaint pas, mais c'est juste qu'elle a l'image de ses organes intimes.

Son objectif, c'est ça. C'est une demande à la patiente. On peut suivre la patiente dans son désir.

Mais là, c'est beaucoup plus le résultat sur le plan anatomique qui doit être parfait. Sinon, vous aurez des problèmes avec cette patiente. Parce qu'elle veut avoir une image d'estime pour elle, donc c'est plutôt une image anatomique.

Par exemple, pour une patiente qui a 75 ans et qui n'est pas très active, si on surcorrige les prolapsus, la patiente peut développer des douleurs post-opératoires. Est-ce que vous avez rendu service à cette patiente? Non. Vous pouvez corriger les années anatomiques, mais la satisfaction de la patiente ne sera pas bonne.

C'est pourquoi il faut toujours réfléchir sur la plainte et sur la demande de la patiente. C'est pourquoi il faut informer, donner un, deux, trois rendez-vous, donner un temps de réflexion à la patiente avant de décider du traitement chirurgical et du choix de la méthode chirurgicale, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, toujours dans la chirurgie, faut-il conserver l'utérus ou l'enlever? Il y a des techniques conservatrices, il y a des techniques radicales avec l'hystérectomie.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne corrige jamais un prolapsus par une hystérectomie simple. Ça, c'est l'erreur fatale, et c'est une erreur qu'on rencontre tous les jours. Si quelqu'un fait une hystérectomie simple pour corriger un prolapsus, c'est qu'il y aura une aggravation du prolapsus, il y aura une aggravation de la plainte, et même pour reprendre chirurgicalement cette patiente, ça serait hyper difficile et une opération risquée parce qu'on modifie l'anatomie.

Donc, c'est quelque chose à bannir. La deuxième question sur l'utérus, est-ce que laisser ou enlever l'utérus change quelque chose? Ça ne change rien dans le traitement du prolapsus. Le traitement du prolapsus, ce n'est pas l'hystérectomie.

On laisse l'utérus, on l'enlève, c'est le même résultat. Le traitement repose sur autre chose. Quand on veut proposer à la patiente, j'ai écouté la patiente, j'ai vu ses plaintes et tout ça, il faut dire à la patiente, qu'est-ce qui vous dérange? Là, s'il veut vraiment se faire opérer, d'accord.

Donc normalement, la première des choses, à part un certain nombre de complications, il faut toujours proposer à la patiente une abstention. Et après, quand vous lui dites qu'on peut s'abstenir, elle va commencer encore à reprendre ses plaintes et tout ça. Et là, on voit que c'est une question chirurgicale.

C'est à ce moment-là qu'on opère la patiente. Donc, il faut retenir qu'on ne peut rien faire devant un prolapsus, surtout qu'il ne dérange pas. Prendre toujours le temps de réflexion, c'est capital.

Et puis, quand on propose la chirurgie, il faut essayer de corriger l'ensemble des troubles et l'ensemble des compartiments en un seul temps. Alors, le traitement chirurgical repose sur différentes méthodes, mais en particulier la restauration. Alors, les moyens de suspension, c'est en haut.

C'est les ligaments, d'accord, qui tirent vers le haut. Le soutènement, c'est en bas. Vous mettez, il faut que ça tire en haut.

Donc, on peut utiliser soit les moyens, le système de suspension, soit des moyens de soutènement. Il faut penser aux complications, aux troubles qui sont secondaires à la chirurgie. Donc, si on n'étudie pas les signes urinaires correctement, s'il y a une dysurie, on va aggraver le problème.

Il faut faire de l'autosondage pour vider la vessie par la suite. Ça va être très délicat, d'accord. Donc, c'est pourquoi il faut connaître, chercher les différents signes qui doivent nous faire plus attention à ces complications.

Aussi, je parlais tout à l'heure du problème sexuel, et aussi la même chose pour le rectum. Alors, en général, on dit qu'il y a autant de prolapsus que de techniques chirurgicales pour traiter le prolapsus. Donc, il y en a plein, et c'est une bonne chose.

On doit adapter chaque technique opératoire pour les plaintes de la patiente. Et ça, c'est quelque chose de capital pour les indications en matière de traitement. Et s'adapter aux réalités, bien sûr.

Alors, quelles sont les réalités? L'âge, l'état, ce que le patient a déjà opéré, est-ce qu'il a déjà eu une prothèse, les défauts masqués, la qualité des tissus disponibles. Il y a des atrophies vaginales, on sait que ça peut poser des problèmes au niveau chirurgical. Donc, en général, on oppose deux techniques.

Deux voies d'abord, l'aparotomie ou l'aparoscopie, l'océloscopie, mais on ne fait plus de l'aparotomie pour les prolapsus. Donc, en général, l'intervention par voie haute se fait par l'océloscopie actuellement. On ne fait presque plus d'aparotomie pour traiter le prolapsus.

On oppose la voie haute à la voie basse. Et ça, c'est quelque chose de capital pour les indications. On va voir les indications de ces deux différentes techniques.

Donc, soit l'océlioïse, soit la voie vaginale. Il y a une amélioration des techniques. En particulier, il y a de nouveaux matériaux de mèches, de prothèses et de cols biologiques.

Donc, la voie haute, je parle de l'océlioscopie. La voie basse, c'est la triple opération par voie basse. Ce qui est classique, c'est l'hystérectomie par voie basse, cure de la cistocèle par le fascia d'Alban.

Ce que je fais personnellement, c'est beaucoup plus le plastron, ce qu'on appelle la technique du plastron vaginal. On laisse un long bout vaginal attaché à la vicié et qu'on va l'amarrer à l'arc tendineux du fascia pelvien. Et puis, le bout, le segment postérieur, on peut l'amarrer à l'épine sciatique.

À un moment donné, on a vu pendant une vingtaine d'années, les techniques par prothèse, par mèche, qui sont faites par voie vaginale. Là, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de complications, en particulier d'érosion. Il y a une exposition de ces prothèses à l'extérieur avec risque de surinfection.

Et ça peut conduire à des cas très graves. Actuellement, ces prothèses faites par voie vaginale sont interdites aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe. On n'utilise que le tissu de la femme.

C'est pourquoi nous avons développé cette technique du plastron. Au lieu de mettre une mèche, une prothèse, on prend un lambeau vaginal et on le rattache à des éléments solides au niveau du pelvis. Pour les incontinences urinaires, quand elles sont associées au prolapsus, avant, on les traite en même temps que le prolapsus.

On sait qu'actuellement, 30 % des incontinences urinaires se corrigent juste avec le traitement du prolapsus et que 30 % des incontinences urinaires d'effort vont apparaître après la correction du prolapsus. La décision prise, c'est qu'on ne fait plus de gestes sur l'incontinence urinaire avant de corriger le prolapsus. On traite le prolapsus et on voit ce qui se passe dans les six mois après la correction du prolapsus.

S'il y a une incontinence qui apparaît ou s'il y a une incontinence qui était là et qui persiste, c'est à ce moment-là qu'on corrige le prolapsus. Il y a deux techniques, soit TVT, soit TOT. Dans les indications, je n'aime pas parler de l'âge parce que dans la réalité quotidienne, ce que je fais personnellement, ça dépend du regard.

Quand je vois un patient, peut-être qu'il a 35 ans, il fait encore du sport, il court, il est hyperactif et tout ça. Et des fois, je vois des femmes à 50 ans, multi-tardées, elles n'ont aucune activité. Ça change tout.

On oppose à des techniques qui sont solides, durables, c'est les techniques faites par voie haute. Les techniques par voie basse, il y a plus de récurrence dans les années à venir. Les techniques les

plus solides, c'est la voie haute.

Les techniques moins solides, c'est la voie basse. Par contre, la voie haute, elle expose à plus de complications et la convalescence est beaucoup plus longue. Par rapport à la voie vaginale, la patiente peut sortir le jour même, il n'y a pas d'incision visible, la douleur est moindre et le rétablissement est rapide, la convalescence est rapide.

Donc le choix va se porter en fonction de l'âge, mais au niveau de l'activité de la femme et ses tarifs. Plus elle est jeune, plus elle est encore active, on va opter pour les techniques par celluloscopie, avec prothèse, par voie haute. Pour les femmes très âgées, qui n'ont peut-être plus de sexualité, qui ne bougent pas trop, qui ont des tards associés, on propose les techniques par voie vaginale.

Pour la celluloscopie, on fait deux prothèses, une prothèse antérieure intercalée entre le vagin et la vicié, et une prothèse intercalée entre le rectum et le vagin. Les deux prothèses sont amarrées au niveau du promontoire. C'est ce qu'on appelle la promontofixation, qui est la technique standard pour le traitement du prolapsus à l'heure actuelle.

La promontofixation par celluloscopie, c'est la technique privilégiée à l'état actuel. Et puis cette promontofixation peut être associée à d'autres techniques. Là, si on opte pour l'hystérectomie, on fait une hystérectomie subtotale, on laisse le col, parce que si on enlève le col, il y a un risque d'érosion de la prothèse.

La prothèse sort à travers le vagin et peut être responsable d'infections, et des infections parfois très graves. Donc on laisse le col. Cette promontofixation, l'hystérectomie, ça ne change rien.

On laisse l'utérus, on l'enlève, ça ne change rien du tout au niveau des résultats, aussi bien fonctionnels qu'anatomiques. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème de conservation au nom de l'utérus. C'est une technique qui repose sur la mise en place de prothèses, de mèches par voie haute.

Pour la promontofixation, avec le temps, avec le développement matériel au niveau des caméras, on a une définition des images beaucoup plus importante qu'en la parotomie. Avant, la promontofixation par cellules était une technique très difficile, parce qu'on fait des sutures et tout ça, on fait de la dissection et tout ça, c'était très difficile. On la faisait entre 3 à 5 heures pour faire cette technique.

Actuellement, avec l'amélioration du matériel, c'est une technique qu'on peut faire en 45 minutes, et même la patiente peut sortir le jour même. C'est pourquoi la promontofixation est devenue un goal standard dans la chirurgie de prolapsus. Ça, c'est pour les techniques.

On fait une dissection antérieure entre l'utérus, le vagin et la vicié. En postérieure, on dissèque entre le rectum et la vicié. On dissèque au niveau du promontoire, et on met deux prothèses, une

antérieure, la mèche postérieure, la mèche antérieure, les deux amarrées au niveau du promontoire, et on pelotonise et c'est fini.

Concernant la voie vaginale, en général, si on veut être logique, parce qu'on va trouver des opérateurs qui sont beaucoup plus celluloscopistes, donc ils vont proposer de la celluloscopie pour tout le monde, ou d'autres qui ne savent pas faire de la cellulose sont vaginalistes, ils vont proposer la voie vaginale pour tout le monde. L'idéal, c'est d'avoir un chirurgien qui fait les deux, comme ça, il adapte. Le choix de la technique va dépendre de la patiente, pas de lui.

Ça, c'est quelque chose de capital. Donc, patiente jeune, espérance de vie élevée, non tarée, on propose la voie haute. Patiente très âgée, fragile, il vaut mieux la voie basse.

Donc, avantage de la voie basse, c'est l'accès direct au défaut du ligament pélvien, centre tendineux et du ligament sacro-épineux. C'est l'intervention de Richter. La mortalité et l'hémorragie sont trois fois moindres par rapport à la parotomie et la cellulose.

Les limites de la voie vaginale, il faut deux assistants et ça pousse trois personnes dans un espace limité, ça bouscule un petit peu. Large dissection, des hémorragies, des difficultés par la suspension par les aiguilles pour avoir accès au ligament sacro-épineux, ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a du douleur pour les myographies, du releveur.

Les cicatrices vaginales, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en général, aussi pour l'anesthésie, la voie haute, c'est anesthésier obligatoirement une anesthésie générale. Par voie basse, ça se fait sous anesthésie.

C'est pourquoi, quand on a une patiente multitarée, obèse, on préfère la voie vaginale plutôt que la cellulose. Approchez-vous. Ça, c'est la voie vaginale.

C'est l'intervention de Richter. Ça, c'est la cure de la cystose L par le fascia d'Alban. C'est un fascia qui se situe entre la viscée et le vagin.

Ça, c'est moi. Ça, c'est la cystose L. Et ça, c'est le lombo, ce qu'on appelle le plastron vaginal. On le laisse attacher au niveau de la viscée.

Et on va le fixer au niveau de l'arc tendineux, à ce niveau-là, au niveau de l'arc tendineux du fascia pelvien. On l'a fixé des deux côtés. Le côté postérieur, on va le fixer au niveau du ligament sacro-épineux.

Et ça donne ce résultat. Si on fait tous les artifices au niveau vaginal, on arrive quand même à corriger les éléments anatomiques. Mais surtout, on vise la satisfaction.

On vise à corriger les troubles fonctionnels. Je ne sais pas s'il y a une conclusion. Les indications.

Les indications, ça dépend de la gêne ressentie, les troubles associés, de l'âge, de l'état général. Absence thérapeutique, pas d'urgence à traiter, un prolapsus. Absentions licites, ces femmes âgées avec prolapsus ancien bien toléré.

Traitement médical, les mesures hygiéniques et diététiques. Lutte contre l'atrophie cutanéomusculaire et musculaire. Ce n'est pas une radication.

La rééducation du péril, un traitement chirurgical après traitement médical est d'emblée sur le prolapsus. C'est sévère et la plainte est importante. Ne pas opérer le prolapsus sur un quotidien ancien bien toléré.

Le prolapsus minime, les patients désirant encore une grossesse, il vaut mieux retarder l'intervention. Ils peuvent tomber enceintes et accoucher sans aucun problème, les femmes qui ont un prolapsus. Les patients avec un risque chirurgical trop important, il ne faut pas les toucher.

Et les patients hésitants, il faut leur donner le temps. Merci et à l'année prochaine pour les cliniques. Ça fait un temps comme pour les 6 ans, 7 ans, mademoiselle.

Hein, mademoiselle ? Donc pour le moment, 7 ans. Hein ? Ok, bon courage, au revoir.